

Эпидуральная анестезия при операциях на толстом кишечнике у онкологических больных

Кусаинов Б. Р.

Эпидуральная анестезия (ЭА), как компонент анестезиологического пособия, находит все большее применение при оперативных вмешательствах в онкологии, при этом оптимальным условием является развитие эпидурального блока до начала операции (принцип предупреждающей анальгезии). Возникают и новые методики ее использования, что обусловлено как появлением современных препаратов (ропивакаин – нарופן в различных концентрациях), так и совершенствованием технического оснащения (длительная инфузия местных анестетиков в эпидуральное пространство). При этом достигается адекватная ноцицептивная защита пациента, позволяющая значительно уменьшить или исключить полностью применение наркотических анальгетиков и, соответственно, избежать их отрицательных эффектов. Стабильная блокада ноцицептивной импульсации из операционной раны, обусловленная проведением ЭА с катетеризацией эпидурального пространства, гарантирует снижение влияния операционного стресса и позволяет продолжить комплексную антиноцицептивную защиту в послеоперационном периоде.

Цель работы

- обобщение клинического опыта применения ЭА в периоперационном периоде реконструктивно-восстановительных операций на толстом кишечнике.

Материалы и методы

В 2007-2009 гг. в КазНИИ онкологии и радиологии выполнено 112 реконструктивно-восстановительных операций на толстом кишечнике. У 48 больных (42,86%) оперативное вмешательство выполнено в условиях многокомпонентной внутривенной анестезии с ИВЛ и миоплегией. Во второй группе, 64 больных (57,14%), перед операцией был установлен эпидуральный катетер и проводилось комбинированное обезболивание.

Результаты

Интраоперационная гемодинамика у больных, оперированных в условиях ЭА, была более устойчивая, в раннем послеоперационном периоде продленная ИВЛ в этой группе проводилась только

у 3-х больных длительностью до 1 часа, в то время как в первой группе ИВЛ проводилась всем больным от 1 часа до 5 часов. Все больные второй группы отмечали более эффективное обезболивание (оценка по балльной шкале). Отмечено, что перистальтика и выделительная функция кишечника также восстанавливались раньше, чем в первой группе.

Осы зерттеулер мақсат, анестезиялық оқу құралының компоненті ретінде эпидурал жансыздандыруын қолдануды клиникалық тәжірибенің бағасы сонымен бірге ерте операциядан кейінгі кезеңде болып табылды. ЭА қолдану емделушінің қорғауының бірдей ноцицептивонийына жетуге мүмкіндік береді есірткі анальгетиктердің қолдануын санды кішірейтуге мүмкіндік беретін. Бұдан басқа, ИВЛ емделушілердің болуды уақытының кішірейтуі, сонымен бірге бұрышы және ішектердің бөлгіш функциясының қалпына келтіруін ертелеу атап өтеді. Біз ЭА өткізу сезімсіздендіруді тиімді әдіс реконструктивтігі - қалпына келтіргіш операцияларда онкология ауруларында болып табылғанын санаймыз.

Целью данного исследования, являлась оценка клинического опыта применения эпидуральной анестезии, как компонента анестезиологического пособия, а также в раннем послеоперационном периоде. Применение ЭА позволяет достигать адекватной ноцицептивной защиты пациента, позволяющей уменьшить количество применения наркотических анальгетиков. Кроме того, отмечается уменьшение времени пребывания пациентов на ИВЛ, а также более раннее восстановление перистальтики и выделительной функции кишечника. Мы считаем, что проведение ЭА является эффективным методом обезболивания при реконструктивно-восстановительных операциях у онкологически больных.

Objective of this research, the estimation of clinical experience of application epidural anesthetics, as components anestesiologies grants, and also in the early postoperative period was. Using ЭА allows to reach adequate ноцицептивоний protection of the patient, allowing to reduce quality applications of narcotic analgetics. Besides, reduction of time of stay of patients on ИВЛ, and also earlier restoration peristalticum and secretory function of intestines is marked. We consider that procommand ЭА is an effective method of anesthesia at reconstructively-regenerative operations at oncology patients.

Выводы

Считаем, что проведение периоперационного обезболивания на основе ЭА является эффективным методом обезболивания при реконструктивно-восстановительных операциях у онкологических больных.